



INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR

AGOSTO 2026



INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

CRIADA EM 01/05/2020

Revisão 02- 01/08/2023

Revisão 03 – 17/04/2024

Revisão 04 – 14/05/2025

Revisão 05- 17/08/2026

Dr. George Guedes Pereira
Superintendente IWGP

Dr. Nilson Alves Lima Filho CRM/PB 15592
Diretor Técnico

Dr Matheus Soares de Araújo CRM/PB 12922
Diretor Clínico

Sônia da Silva Delgado
Diretora Assistencial

Giulianna Carla Marçal Lourenço
Gerente de Enfermagem

Jacqueline de Almeida Ribeiro
Enfermeira Reguladora



Membros do Núcleo Interno de Regulação

- 1. Nilson Alves Lima Filho (Médico RT)**
- 2. Matheus Soares de Araujo (Médico Assistencial)**
- 3. Giulianna Carla Marçal Lourenço (Enfermeira) Membro**
- 4. Jacqueline de Almeida Ribeiro (Enfermeira Reguladora)
Membro**
- 5. Maria Penha da Silva (Assistente Social) Membro**
- 6. Glaucia Cardoso Santiago de Aquino (Assistente Social)
Membro**
- 7. Renata Luzia Pontes Jacauna Ferreira (Enfermeira
Assistencial) Membro**
- 8. Nivea Lacerda de Azevedo (Enfermeira Assistencial) Membro**
- 9. Sharline Menezes de Sousa Falcão (Enfermeira Assistencial)
Membro**
- 10. Monica Maria Alves (Enfermeira Assistencial) Membro**



Introdução

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) instituída por meio da Portaria de Consolidação n.º 2, de 28 de setembro de 2017, em seu art. 6º, inciso IV, define e recomenda a criação do Núcleo Interno de Regulação (NIR) nos hospitais, que deverá realizar a interface com as Centrais de Regulação; delinear o perfil de complexidade da assistência no âmbito do SUS e disponibilizar consultas ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, além dos leitos de internação, segundo critérios preestabelecidos e protocolos que deverão ser instituídos pelo NIR. Além disso, deve buscar vagas de internação e apoio diagnóstico e terapêutico fora do hospital para os pacientes internados, quando necessário, conforme pactuação com a Rede de Atenção à Saúde (RAS). O Núcleo Interno de Regulação é uma Unidade Técnico-Administrativa que possibilita monitoramento do paciente desde a sua chegada à instituição, durante o processo de internação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. É um órgão colegiado ligado hierarquicamente à Direção-Geral do Hospital e deve ser legitimado, com um papel definido e disseminado dentro da instituição

2.0 Objetivos

2.1 Objetivo Geral Apresentar um modelo que subsidie o gestor hospitalar a implantar o Núcleo Interno de Regulação (NIR) para apoio da Gestão de Leitos, demais ofertas e para propiciar a interface com a Regulação de Acesso, por meio de um manual, com o passo a passo que permita a sua implantação e implementação.

2.2 Objetivos Específicos Promover diretrizes que norteiem os gestores na implantação e implementação do NIR. Dar subsídios técnicos para a elaboração do Regimento Interno e constituição da equipe do NIR. Orientar a realização da Gestão de Leitos Intra-Hospitalares. Dar subsídios técnicos para realização de ações que



qualifiquem o cuidado, a partir das informações advindas do monitoramento da Gestão de Leitos

2.3 Principais Atribuições

A implementação do NIR precisa ser entendida como projeto importante e permanente dentro do planejamento estratégico. Os hospitais são instituições complexas, com rotinas e culturas organizacionais muito enraizadas. O NIR certamente precisará confrontar muitas dessas concepções e, invariavelmente, resistências às mudanças devem ser esperadas. Para obtermos sucesso na implantação do NIR é necessário que haja um sinergismo entre o que a instituição dispõe de melhor com o que é preconizado pelo NIR, sempre com o apoio irrestrito da alta liderança, gerentes, coordenadores etc. Desta forma, iremos minimizar as eventuais resistências e introduzir gradativamente a cultura da eficiência no âmbito hospitalar. Sendo assim, constituem como principais atribuições do NIR:

- ✓ Permitir o conhecimento da necessidade de leitos, por especialidades e patologias.
- ✓ Regular e gerenciar as diferentes ofertas hospitalares existentes, a saber: Ambulatório de HE, ambulatório de QT, Internação, urgência e Emergência. Agendamento cirúrgico e ambulatorial.
- ✓ Subsidiar discussões tanto internas, como externas (na Rede de Atenção à Saúde – RAS), que permitam o planejamento da ampliação e/ou readequação do perfil de leitos hospitalares ofertados.
- ✓ Otimizar a utilização dos leitos hospitalares, mantendo a Taxa de Ocupação em limites adequados (evitando tanto ociosidade como superlotação) e controlando o Tempo Médio de Permanência nos diversos setores do hospital, além de ampliar o acesso aos leitos e a outros serviços disponibilizados pela RAS.
- ✓ Otimizar a ocupação das Salas Cirúrgicas. Monitorar com finalidade de reduzir ao máximo o número de procedimentos eletivos cancelados/suspensos.
- ✓ Estabelecer mecanismos de apoio na perspectiva da redução do tempo de espera entre a indicação de terapia cirúrgica e a realização do procedimento.



- ✓ Estabelecer e/ou monitorar o painel de indicadores da capacidade instalada hospitalar. Induzir a implantação dos mecanismos de gestão da clínica tais como Kanban, Projeto Terapêutico Singular, Gestão da Fila.
- ✓ Promover o uso dinâmico dos leitos hospitalares, por meio do aumento de rotatividade e monitoramento das atividades de Gestão da Clínica desempenhadas pelas equipes assistenciais.
- ✓ Permitir e aprimorar a interface entre a gestão interna hospitalar e a regulação de acesso hospitalar.
- ✓ Qualificar os fluxos de acesso aos serviços e às informações no ambiente hospitalar. Otimizar os recursos existentes e apontar necessidades de incorporação de tecnologias no âmbito hospitalar.
- ✓ Promover a permanente articulação do conjunto das especialidades clínicas e cirúrgicas, bem como das equipes multiprofissionais garantindo a integralidade do cuidado, no âmbito intra-hospitalar.
- ✓ Aprimorar e apoiar o processo integral do cuidado ao usuário dos serviços hospitalares visando ao atendimento mais adequado às suas necessidades.
- ✓ Apoiar as equipes na definição de critérios para internação e instituição de alta hospitalar responsável.
- ✓ Fornecer subsídios às Coordenações Assistenciais para que façam o gerenciamento dos leitos, sinalizando contingências locais que possam comprometer a assistência. Estimular o Cuidado Horizontal dentro da instituição.
- ✓ Subsidiar a direção do hospital para a tomada de decisão internamente e quando o Hospital dispor de Núcleo de Acesso à Qualidade (NAQH) pautá-lo sobre o padrão de utilização de ofertas para tomada de decisão estratégica.
- ✓ Colaborar tecnicamente, com dados de monitoramento, na proposição e atualização de protocolos/diretrizes clínicas e terapêuticas e protocolos administrativos.
- ✓ Regular e agendar exames externos e internos.
- ✓ Realizar conferência de vaga in loco
- ✓ Participar de round profissionais
- ✓ Monitorar indicadores
- ✓ Elaborar e alimentar atas, relatórios e planilhas.
- ✓ Atualizar POP's.



- ✓ Cumprir e fazer cumprir o regimento interno do NIR.
- ✓ Conferir documentação de solicitação e encaminhar ao médico regulador.
- ✓ Comunicar ao posto de enfermagem a decisão e admissão.

- ✓ Realizar busca de absenteísmo de exames e consultas.
- ✓ Enviar respostas de solicitação de vaga ao NIR da unidade solicitante, na ausência do médico regulador.
- ✓ Monitorar as respostas de solicitações de vagas externas, com finalidade de agilizar o fluxo de transferência de paciente.
- ✓ Participar de treinamentos dos fluxos com equipes assistenciais.
- ✓ Realizar visita a beira leito avaliando quadro de pacientes, discutindo possíveis remanejamentos e transferências em conjunto com a equipe assistencial.
- ✓ Realizar e registrar ligações para pacientes avisando a mudança de data e turno de procedimentos dos fluxos e protocolos relacionados aos processos de trabalho do NIR
- ✓ Participar da construção e implantação.
- ✓ Enviar censo atualizado diariamente e garantir a eficiência na alocação de recursos, primeiro envio até as 08h, segundo envio até as 14h e terceiro envio até as 20h. Importante ressaltar que caso haja atualização do censo de leitos antes dos referidos horários limites, o censo deve ser encaminhado logo que disponível atualização.
- ✓ Comunicar ao posto de enfermagem a admissão de cada paciente.
- ✓ No início do plantão o enfermeiro do NIR deverá apoiar a equipe assistencial dos setores na avaliação dos pacientes em observação, para verificar a viabilidade de serem transferidos para enfermarias, UTI ou alta para casa.

3.0 Estrutura de Recursos Humanos

O Núcleo Interno de Regulação terá funcionamento de segunda a sexta – feira, das 07h às 17h, de forma descentralizadas, para o desenvolvimento das suas atividades dentro do HSVP. Em horário que não houver funcionamento da equipe do NIR, os enfermeiros e médicos da unidade da urgência e emergência ficarão responsáveis por regulação de leitos, internações e transferências de pacientes.



Para executar todas as atividades propostas, o NIR precisará do apoio de profissionais de outros setores do hospital, como coordenadores de unidade para alinhamento de rotinas e processos, do departamento de informática para coleta e processamento de dados dos indicadores, dos colaboradores para aplicação dos protocolos administrativos e médico-assistenciais etc.

Hospitais de maior porte geralmente demandam maior número de recursos humanos atuando exclusivamente no NIR, de acordo com sua complexidade e tamanho da capacidade instalada. Nesses casos, é comum a inclusão de colaboradores administrativos e maior número de médicos e enfermeiros em dedicação exclusiva, pois há grande demanda de trabalho de regulação e manejo de leitos em tempo real. Para um hospital menor, entretanto, estruturas mais enxutas, porém bem organizadas, podem gerar bons resultados; de qualquer forma, é preciso adequar a expectativa e o escopo de atuação com os recursos humanos que estarão disponíveis para o trabalho.

3.1 Os três Pilares do NIR

Ainda que possa haver grande variabilidade no escopo e nas ações do NIR entre hospitais gerais, existem três grupos de atividades que são fundamentais para otimizar o uso da capacidade instalada do hospital:

Práticas de Regulação

São atividades transversais de regulação do acesso realizadas pelo NIR, de forma articulada com os pontos de atenção e as Centrais de Regulação com o intuito de otimizar os recursos assistenciais disponíveis na unidade hospitalar.

Articulação com a RAS

Interface com as Centrais de Regulação Hospitalar e com outras instituições da rede (Unidades Básicas de Saúde - UBS, Unidades de Pronto Atendimento - UPA, hospitais etc.).

Monitoramento



Avaliação de indicadores, do fluxo do paciente e de casos de permanência prolongada.

4.1 Práticas de Regulação

As práticas de regulação consistem em atividades que articulem o NIR e os pontos de atenção da RAS, de modo a definir, organizar e acompanhar o fluxo dos usuários e o acesso às ações e aos serviços de saúde. É extremamente importante o estabelecimento de uma rede de comunicação entre o NIR e as Centrais de Regulação (Ambulatorial, Hospitalar e de Urgência) para efetivar o acesso do usuário em tempo oportuno e adequado ao recurso necessário. Neste sentido, a capacidade instalada do hospital precisa ser utilizada de forma racional e adequada, beneficiando o maior número de pacientes em um determinado período. Quando falamos em regulação do acesso, estamos dizendo que é importante selecionar e alocar corretamente o paciente no recurso hospitalar que contemple as suas necessidades. Isso vale para a estrutura de internação hospitalar e para a estrutura ambulatorial de especialidades médicas, bem como a complexidade tecnológica a elas associada. O desperdício de capacidade instalada pode resultar de simples ociosidade ou por encaminhamento inadequado (alocar o paciente para recurso que não contempla a sua necessidade). Essa última situação é, frequentemente, uma das causas de ineficiência do uso da capacidade instalada e de risco a segurança dos pacientes. Um paciente grave que necessite de recursos de terapia intensiva terá seu tratamento adiado se for alocado em um leito de enfermaria clínica e, até que o erro seja corrigido, correrá risco adicional pela insuficiência de recursos na estrutura em que foi alocado. De forma semelhante, um paciente que necessite de procedimento vascular de urgência, devido a uma trombose arterial aguda, pode acabar tendo o membro amputado se for internado em um hospital sem equipe de cirurgia vascular. Nessas situações, acabamos consumindo o recurso sem resolver o problema de saúde do usuário, muitas vezes ainda agravando sua situação.

4.1.1 Complexidade de Atendimento



Os hospitais possuem perfil de complexidade muito variável, conforme os recursos diagnósticos e terapêuticos de que dispõem. Normalmente, não estão aptos a tratar todas as condições dos pacientes que procuram atendimento espontaneamente na sua principal porta de entrada, o setor da Emergência.

Equipes especializadas e qualificação do Corpo Clínico Que especialidades médicas trabalham no hospital e qual suporte multidisciplinar existe. Definir que especialidades internam ou apenas consultam no ambulatório, se os especialistas do ambulatório dão apoio aos médicos dos setores para o cuidado especializado dos pacientes internados, em que dias da semana ou turnos temos a disponibilidade de tais serviços etc. Definir, também, quais doenças o corpo clínico está ou não apto a tratar e quais os medicamentos disponíveis. Complexidade tecnológica mapear quais recursos diagnósticos e terapêuticos estão disponíveis na unidade hospitalar para que os profissionais possam tratar as doenças específicas. Caso contrário, teremos desperdício de mão de obra qualificada, consequentemente de recursos financeiros e prejuízo para o paciente. A partir do mapeamento desses itens, podemos definir critérios de elegibilidade para internação e/ou encaminhamento para o centro de referência, conforme pactuação na RAS. Esses critérios deverão ser incorporados aos protocolos institucionais de internação que abordaremos adiante.

4.1.2 Gravidade dos Pacientes Definida a complexidade de atendimento que podemos oferecer aos pacientes, precisamos definir como alocar os pacientes graves nos locais mais adequados do hospital.

Entenda-se por paciente grave o paciente instável, com risco potencial de deterioração clínica e que demanda cuidados frequentes e/ou intensivos. Existem diversos escores de alerta precoce e de avaliação objetiva da gravidade do paciente, a exemplo do escore Modified Early Warning Score (MEWS – referência disponível ao final do Manual), cuja discussão pormenorizada vai além do escopo deste Manual. Esses escores podem ser consultados como base para a definição de critérios objetivos de estabilidade clínica. Em geral, esses critérios contemplam valores de sinais vitais, medidas de glicemia capilar e de saturação periférica de oxigênio, sinais de esforço ventilatório, avaliação do nível de consciência, uso de oxigênio suplementar, entre outros.



4.1.3 Padronizar as Transições de Cuidado entre Unidades com Ferramentas de Gestão da Clínica.

É importante esclarecermos o conceito de gestão da clínica, aqui colocada como ferramenta de gestão na perspectiva de melhoria de qualidade e do controle dos seus determinantes, com foco na eficiência e na efetividade. Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a necessidade de criarmos mecanismos de eficiência no setor Saúde, que possam controlar o avanço dos gastos devido ao aumento crescente de demanda e de consumo de tecnologias, de forma a considerar a eficiência e a eficácia dos serviços prestados e com base em modelos internacionais que têm como premissa a universalidade do direito e do acesso, os quais propõem a integralidade do cuidado, na busca do gerenciamento clínico como caminho para se obter melhor performance dos serviços de saúde. Nessa perspectiva, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem avançado, a partir de estratégias de qualificação que, com bases nessas premissas e na busca por ofertar melhor serviço ao usuário, tem pouco a pouco tentado implementar e capacitar profissionais para isso, propomos soluções combinadas nas quais seja possível melhorar desde as práticas clínicas, transformando-as em seguras, ao mesmo tempo em que se produz melhorias nos sistemas de saúde, redesenhando a Rede de Atenção à Saúde, implementando modelos de regulação que se adequem às regiões, utilizando conceitos de linhas de cuidados e da clínica ampliada para dentro dos espaços assistenciais. Incluindo toda a equipe multiprofissional na elaboração e discussão do projeto terapêutico do usuário dos serviços de saúde. Além da inserção de diversos dispositivos no âmbito da gestão hospitalar, dando ênfase a: implantação do acolhimento com classificação de risco; inserção de equipes de referência, com escala horizontal nos diversos setores do ambiente hospitalar; implantação dos núcleos de segurança do paciente; implantação de colegiados de gestão e grupos técnicos de humanização; implantação de equipes de gestão e controle de permanência, com a implementação, por exemplo, do método Kanban; criação de núcleos de educação permanente; protocolos clínicos e administrativos, além da implantação do NIR, objeto deste Manual.

Após definirmos objetivamente os critérios de internação, conforme a complexidade, bem como os critérios de gravidade, recomendamos a institucionalização de protocolos, a fim de padronizar e homogeneizar a transição de cuidados entre as unidades do hospital. É imperativo que se desenvolva ao menos um protocolo de internação que contemple a transição de cuidados do setor da



Emergência para as demais unidades. Recomendamos a Padronização e uso de Protocolos na transição entre áreas, como por exemplo: transição da UTI para Enfermaria Clínica e vice-versa; Sala de Recuperação Cirúrgica para Enfermaria Cirúrgica etc. Os protocolos devem possuir critérios objetivos que permitam classificar e alocar corretamente os pacientes para os locais com recursos adequados para as necessidades da sua patologia e da sua gravidade clínica. Dessa forma, evita-se desperdício de uso da capacidade instalada e promovemos um tratamento mais seguro, eficaz e resolutivo. Para que funcionem na prática, esses processos precisam ser compreendidos por todos os colaboradores, por isso sugerimos que sejam elaborados e discutidos em conjunto com os profissionais que o utilizarão, para o empoderamento e maior adesão. É necessário a interação com a alta liderança e coordenações das áreas, a capacitação dos profissionais envolvidos e que sejam realizadas revisões periódicas. Sugerimos que a sua aplicação, na prática, seja realizada pela equipe de multiprofissional. Ressalta-se a importância do alinhamento entre os coordenadores dos setores envolvidos com o cuidado, de forma a propiciar o trabalho integrado. É preciso fomentar a padronização da assistência por meio de protocolos médico-assistenciais e administrativos, bem como da prescrição e evolução médica, emissão de Autorização para Internação Hospitalar (AIH) e outros documentos pertinentes. Devem contribuir para o Controle de Infecção Hospitalar (CIH) e Segurança do Paciente por meio da inclusão de protocolos de prevenção de eventos adversos, precauções de contato e isolamento para situações específicas, além das seis metas internacionais recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

4.2 Relacionamento Interno e Externo

(Articulação com a RAS) Após ter organizado o acesso a sua capacidade instalada e padronizado os fluxos de pacientes dentro da instituição, o NIR está apto a exercer o papel de interlocutor entre o hospital e as Centrais de Regulação e demais instituições de saúde da Rede. Não podemos esquecer de que o objetivo final de todo o trabalho é beneficiar o maior número possível de pacientes, aumentando a oferta não só pela qualificação do acesso, mas também das indicações de transferências entre instituições.

É importante destacar que a Política Nacional de Atenção Hospitalar traz o conceito de alta responsável como um mecanismo de transferência de cuidados



realizado por meio da orientação dos pacientes e familiares quanto à continuidade do tratamento, reforçando a autonomia do sujeito, proporcionando o autocuidado; articulação da continuidade do cuidado com os demais pontos de atenção da RAS, em particular a Atenção Básica e implantação de mecanismos de desospitalização, visando alternativas às práticas hospitalares, como as de cuidados domiciliares pactuados na Rede de Atenção à Saúde (RAS). Desta forma, é de fundamental importância o apoio do NIR para discussão e implementação da proposta da Alta responsável, como dispositivo para articulação dos processos de trabalho das equipes, gestores e Redes de Atenção à Saúde, visando à integralidade e continuidade do cuidado em saúde dos usuários nos territórios. Um exemplo de formulário usado no processo de alta responsável adotado em hospital terciário no interior do estado de São Paulo está disponível ao final do Manual, no Anexo B. Cabe ainda citar que o NIR deve participar dos Núcleos de Acesso e Qualidade Hospitalar (NAQH), descritos também na portaria da Política Nacional de Atenção Hospitalar. Esse outro núcleo é composto por profissionais das diversas áreas do hospital e de representantes da gestão, com a finalidade de garantir a qualidade da gestão do serviço de urgência e emergência e dos leitos de retaguarda às urgências e à interlocução com a RAS.

4.2.1 Centrais de Regulação

O NIR deverá desenvolver uma relação direta, frequente e esclarecedora com as Centrais de Regulação Hospitalar. Um dos desafios enfrentados por essas Centrais, municipais e estaduais, é o de obter informações claras e apuradas sobre os pacientes que precisam ser transferidos entre as instituições da rede. Muitas vezes, nem mesmo um censo de leitos da região regulada consegue ser apurado com exatidão e em tempo hábil. O NIR deve filtrar (esclarecendo com o médico-assistente em situações de dúvida quanto a determinados encaminhamentos, repassando uma informação clara para a Central de Regulação), bem como monitorar as solicitações de transferência externa, utilizando seu relacionamento mais próximo à Central de Regulação para sinalizar casos que precisam de resolução com brevidade e devem ser priorizados. Por fim, o NIR deve ainda informar o censo de leitos local periodicamente, disponibilizando leitos de internação, sempre que possível, para pacientes de outras instituições da Rede. Precisa, ainda, delinear claramente os



critérios de elegibilidade para essas admissões, conforme o perfil assistencial do hospital.

4.2.2 Outras Instituições

O relacionamento direto com o NIR de outros hospitais é uma atividade importante que precisa ser desenvolvida para a troca de experiências, bem como a criação e alinhamento de fluxos específicos. Mais do que isso, dessas relações podem surgir parcerias para compartilhamento de recursos diagnósticos e terapêuticos. Como exemplo, vamos considerar dois hospitais gerais com limitações de recursos para exames diagnósticos. O hospital A possui tomógrafo, mas carece de ecocardiografia; enquanto que o hospital B possui ecocardiografia, mas não dispõe de um aparelho de tomografia computadorizada. O NIR de ambos hospitais podem encontrar aqui a solução para esperas prolongadas de transferência, bastando alinhar um fluxo específico de pacientes entre as instituições para realização desses exames.

Manual de Implantação e Implementação Núcleo Interno de Regulação para Hospitais Gerais e Especializados Essa mesma lógica pode ser expandida para cirurgias menores, consultas especializadas etc. Para ilustrar, imagine um hospital geral que não conte com equipe especializada em Urologia e tenha dificuldades em transferir pacientes com obstrução aguda do trato urinário por cálculos renais. Agora, imagine na mesma cidade um hospital especializado, com médicos residentes em Urologia que estão ociosos, que não podem realizar esses procedimentos, pois a superlotação da Emergência obrigou a disponibilização dos leitos da Urologia para pacientes de outras especialidades. Então, considere que o NIR do hospital geral organize um fluxo para realização do procedimento no hospital especializado, com retorno do paciente para o hospital de origem logo após a sua realização, sem utilizar a estrutura de enfermaria cirúrgica do hospital especializado. Nesse tipo de situação, beneficiaríamos o paciente, os hospitais e as equipes assistenciais envolvidas.

4.3 Monitoramento

Como toda ferramenta de gestão, o NIR também precisa mensurar o resultado de suas ações (efetividade e eficiência). É por meio do monitoramento de indicadores que saberemos o desempenho real do NIR e poderemos identificar áreas com oportunidade de melhoria. Um indicador deve gerar uma informação relevante para o

processo de gestão e planejamento, precisa ser claro, objetivo e derivado de dados confiáveis. Muitos hospitais gerais ainda não contam com sistemas de informação internos totalmente informatizados, e a obtenção dos indicadores, nesse contexto, pode tornar-se trabalhosa e difícil, dependendo da estrutura de recursos humanos que o NIR apresenta. Por isso, sugerimos que se comece com poucos indicadores, aqueles que são essenciais e que podem ser obtidos mais facilmente e com dados confiáveis. Podemos dividir os indicadores relevantes para o NIR em dois grupos principais: os de processo e os de resultado.

4.3.1 Indicadores de Processos

Após padronizar o fluxo de pacientes no hospital, é importante saber se, de fato, esses processos estão ocorrendo de forma eficiente e correta. A maior parte dos indicadores de processos vão mensurar tempos do fluxo do paciente pela estrutura e unidades do hospital, desde a sua admissão até a alta hospitalar. Podemos aqui, também, observar se os protocolos em si estão sendo aplicados e mensurar a adesão dos colaboradores. Importante salientar que, antes de mensurar esses indicadores, é importante ter o processo mapeado, com as equipes capacitadas na sua execução. Como exemplo, podemos citar:

Tempo para efetivação de internação: Avalia o tempo decorrido desde a solicitação de internação na Emergência até a chegada do paciente na Unidade de Internação. Processos de admissão homogêneos deverão apresentar tempos adequados dentro de uma estimativa real de sua duração. A transferência do paciente da Emergência para a Enfermaria Clínica revela-se um processo complexo, no qual diversas etapas acontecem com a interação de vários colaboradores do hospital, desde o médico até administrativos. A redução nesse tempo pode sensivelmente reduzir a superlotação na Emergência.

Tempo para efetivação de alta hospitalar: Mensura o tempo decorrido da definição médica de alta do paciente até a desocupação do leito. A redução nesse indicador gera aumento virtual da capacidade instalada, ao aumentar o giro de leitos e sua oferta para novas admissões. Alguns hospitais ainda mensuram o horário da alta hospitalar; estimula-se as equipes a promoverem a alta no turno da manhã, permitindo que à tarde um novo paciente já ocupe o mesmo leito. Cabe o cuidado de mensurar e avaliar com cautela essa questão, uma vez que o fato do paciente receber a alta não implica na imediata desocupação do leito, e outros fatores costumam estar presentes nesta



etapa. Novamente, um mapeamento preciso do processo poderá auxiliar no uso da informação gerada a partir dos dados do indicador. Manual de Implantação e Implementação Núcleo Interno de Regulação para Hospitais Gerais e Especializados.

Tempo para higienização do leito: Compreende o tempo decorrido desde a saída física do paciente até o momento de liberação do leito já higienizado. A exemplo do indicador anterior, a redução da duração dessa etapa também aumenta a oferta real de leitos para novas admissões.

Tempo de intervalo entre cirurgias: A redução nos tempos de transferência do paciente para a Sala de Recuperação e higienização da Sala Cirúrgica aumenta a disponibilidade dela para novos procedimentos, expandindo o número de cirurgias possíveis para um determinado período.

4.3.2 Indicadores de Resultado

Esses são os indicadores que mostram o efeito real das ações que serão desencadeadas pelo NIR, e muitos refletem o funcionamento global do hospital. Enquanto os indicadores de processo mensuram a eficiência das atividades desenvolvidas, os indicadores de resultado apontarão se essas atividades são de fato eficazes no cumprimento dos seus objetivos. Quando falamos em resultado, podemos ainda subdividir esses indicadores em produção e desempenho. Produção diz respeito ao uso da capacidade instalada e ao número de atendimentos. Indicadores de produção básicos incluem:

- ✓ Pacientes-dia no período.
- ✓ Taxa de ocupação dos leitos.
- ✓ Número de internações clínicas e eletivas
- ✓ Número de consultas (município e estado)
- ✓ Número de cirurgias total mês.
- ✓ Taxa de ocupação de Salas Cirúrgicas.
- ✓ Taxa de consultas realizadas.

Os indicadores de produção mostram-nos, em última análise, se a capacidade instalada está sendo adequadamente utilizada, indicando desperdício por ociosidade da estrutura quando estiverem abaixo da sua meta. Ainda, indicadores muito elevados podem indicar um excesso de demanda para a oferta, principalmente se os



indicadores de desempenho (descritos a seguir) estiverem adequados. Os indicadores de desempenho, portanto, mostram se a capacidade instalada está sendo utilizada de forma eficiente. Como exemplo, podemos citar:

- ✓ Tempo médio de permanência em leito de internação.
- ✓ Taxa de pacientes residentes no hospital (permanência superior a 90 dias).
- ✓ Índice de renovação (giro de leitos).
- ✓ Índice de intervalo de substituição (intervalo de substituição de leitos).
- ✓ Giro de Salas Cirúrgicas (cirurgias no período/número total de salas).

Melhorar o desempenho do fluxo do paciente no hospital, levando em consideração a aplicação de melhores práticas médico-assistenciais bem como promovendo processos administrativos organizados e eficientes, será fundamental para reduzir a superlotação no setor da Emergência. Precisamos destacar que o NIR, sozinho, não poderá intervir em cada ponto dessa cadeia complexa de serviços de assistência em saúde; não obstante, deve organizar a análise e compartilhar as conclusões com a direção técnica e administrativa. Essas informações serão indispensáveis na concepção e controle dos planos de ação que precisarão ser implantados para otimizarmos o uso da capacidade instalada. Os exemplos de indicadores aqui citados incluem os que usualmente são utilizados para o processo de gestão. Contudo, nada impede que outros indicadores sejam criados, conforme as particularidades de cada instituição e do contexto em que estão inseridas. Basta lembrar, sempre, que o indicador precisa ser de fácil obtenção, acurado e relevante para a avaliação do processo. Abordar em detalhes a gestão de processos que está além do escopo deste Manual, mas sugerimos o uso de ferramentas gerenciais específicas, como os ciclos de PDCA (Plan, Do, Check and Act) para implantação das mudanças. Como os processos costumam depender de diversos colaboradores e são geralmente complexos, recomenda-se também não implementar muitas mudanças simultaneamente, pois o resultado de uma intervenção modifica toda a cadeia de processos. Nesses casos, múltiplas alterações concomitantes podem anular as melhorias esperadas, pois elas foram elaboradas considerando apenas a formatação original do processo em questão.



5.0 Bloqueio de leitos

Quando houver necessidade bloqueio de leitos por motivos de manutenção ou recursos humanos e em caso de necessidade do bloqueio por motivo de precaução de contato ou precaução respiratória, o NIR deverá sinalizar no censo de vagas encaminhado diariamente para CIH e CERH.

6.0 Solicitação de transferência externa

Quando o HSVP não possuir recursos para prover o tratamento adequado ao paciente que está internado seja por não ser nosso perfil ou pelo fato de o paciente não estar contractualizado, a equipe assistencial deve solicitar a transferência para outra instituição que possua o recurso adequado pelo paciente. A solicitação para transferência deve ser feita em formulário atualizado da CIH ou CERH para transferência. O formulário deve ser preenchido por história clínica breve do paciente, exame físico, exames subsidiários CID diagnóstico e especialidade ou recurso solicitado (especialidade, leito etc.). Após preenchido o formulário, o mesmo deverá ser encaminhado ao NIR com cópias, exames laboratoriais e laudos de exames de imagem e/ou outros quando pertinente ao caso. A solicitação para transferência externa deve ser realizada ao menos uma vez a cada turno (matutino, vespertino e noturno ou cada 6 horas), diariamente, incluindo finais de semana e feriado.

7.0 Regulação de exames externos

Quando pacientes internados no HSVP necessitarem de exame ou procedimentos que é realizado fora da instituição o médico assistente do paciente deve preencher a APAC ambulatorial e sinalizar ao NIR juntamente com cópia legível de documento oficial com foto, cartão SUS, CPF, comprovante de residência atualizado. Após isso o NIR irá encaminhar por e-mail o pedido de solicitação para a coordenação do



SISREG, uma vez autorizado o exame será agendado e comunicado a equipe assistencial e em seguida o NIR providencia o transporte adequado ao paciente.

8. Benefícios

Eficiência Operacional	Redução de espera
	Melhora no fluxo do paciente
	Agilidade nos processos
	Redução de cancelamentos de procedimentos

Qualidade no Atendimento	Satisfação do Cliente
	Melhoria da comunicação
	Redução no tempo de permanência
	Monitorização dos processos

	Controle de riscos e erros
--	----------------------------



Gestão de Recursos	Agendamentos
	Eficiência na utilização de leitos
	Melhoria da capacidade da resposta

9.0 ROTINAS DO NIR

9.1 Rotina Matutina

No início do turno, a equipe do Núcleo Interno de Regulação (NIR) deverá realizar visita aos setores para levantamento e conferência do censo de vagas, verificando a situação dos leitos, a previsão de altas, transferências, remanejamentos e admissões. Deverá também identificar pacientes com necessidade de transferência externa, exames ou procedimentos não disponíveis na instituição.

Quando necessário, deverão ser solicitados exames externos da CIH, tais como:

- Ressonância Magnética (RNM);
- Radioterapia;
- Cintilografia;
- PET-CT;
- Outros exames e procedimentos externos.

Exames realizados no serviço para pacientes do Estado:

- Tomografia Computadorizada;
- Raio-X;
- Ultrassonografia (USG);
- Exames laboratoriais.

9.2. Envio e Atualização do Censo de Leitos

O NIR deverá manter o censo de leitos atualizado, garantindo que as informações encaminhadas às Centrais de Regulação sejam fidedignas e correspondam à situação real dos leitos da instituição.

O censo atualizado deverá ser encaminhado para:

- CIH;
- CERH.



O censo da CERH deverá ser enviado para o grupo de WhatsApp e também para os e-mails:

- CERH: cerh.pb@regulacaopb.com.br
- Auditoria: auditoriasemendaspb@gmail.com

Sempre que houver alteração relevante na disponibilidade de leitos, o censo deverá ser atualizado e encaminhado, independentemente do horário previamente estabelecido.

9.3 Atualizações Diárias

Encaminhar diariamente ao grupo da CERH as seguintes informações:

- Altas hospitalares;
- Óbitos;
- Transferências;
- Remanejamentos de setor.

Atualizar diariamente as planilhas de:

- Admissões de pacientes do Estado;
- Admissões de pacientes regulados (Estado e Município);
- Exames;
- Transferências.

Reiterar, juntamente com o Serviço Social, as solicitações de transferência dos pacientes, acompanhando as respostas e mantendo os registros atualizados.

9.4. Envio do Censo ao Longo do Dia

08h – Encaminhar o censo atualizado de vagas para CIH e CERH.

14h – Encaminhar o censo atualizado de vagas para CIH e CERH.

18h – Encaminhar o censo noturno atualizado para CIH e CERH.

Além dos horários programados, o censo deverá ser atualizado sempre que houver alteração relevante na disponibilidade de leitos.

9.5 Fluxo Noturno

Encaminhar o censo de vagas para CIH e CERH nos seguintes horários:

- 20h;
- 06h.

9.6 E-mails Importantes

Solicitação de ambulância (Estado): cofihsespb@gmail.com



INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

CERH (Estado): cerh.pb@regulacaopb.com

Auditoria do Estado: auditoriasemendaspb@gmail.com

CIH (Município): cih@regulacaojp.com

Solicitação de exames (Município): examespctijp@gmail.com

9.7 Internação de Pacientes do Estado

Todo paciente do Estado admitido pela Urgência somente poderá ser internado mediante apresentação da Senha de Autorização de Internação emitida pela CERH.

Além disso:

- O médico assistente deverá preencher o formulário da CERH.
- O formulário deverá ser encaminhado para cerh.pb@regulacaopb.com.

9.8 Regras Importantes

Toda admissão de paciente do Estado deverá conter obrigatoriamente:

- Senha de autorização da internação emitida pela CERH.
- Todos os procedimentos ambulatoriais do Estado deverão estar com o impresso autorizado pela médica ponto focal do Estado que atua no HSVP, Dra. Mayssa Lacerda, como, por exemplo, biópsias percutâneas e implante de cateter. O documento deverá permanecer anexado ao prontuário do paciente.

9.9 Distribuição dos Leitos

Ala Branca – Enfermaria Onco-Clínica: 11 leitos. (ESTADO)

Ala Azul – Enfermaria Onco-Hematológica: 10 leitos (ESTADO)

UTI: 01 leito contratualizado (ESTADO)

UTI: 01 leito particular

10. Distribuição dos Leitos (Município)

Atuando com 133 leitos, sendo 17 leitos particulares e 116 SUS com dupla gestão Município e Estado.



Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 27 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. 2017. Disponível em: . Acesso em: 30 nov. 2017.

Brasil.Ministério da Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. SISREG – SISTEMA NACIONAL DE REGULAÇÃO. BRASÍLIA: Ministério da Saúde, 2021.

PEITER, C.C; LANZONI, G.M.M; OLIVEIRA, W.F. Regulação em saúde e promoção da equidade: o Sistema Nacional de Regulação e o acesso à assistência em um município de grande porte. Disponível em . Acesso em 19 fev. 2020.

MARCONI, M.A; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens, e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 87,103,130.